

A. Connaître la place et les anomalies de la radiographie thoracique des quatre urgences cardio-vasculaires

Rôle limité de la radiographie de thorax dans ce contexte +++ , TDM = examen clé urgent pour dissection et embolie pulmonaire

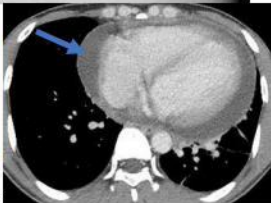
Péricardite aigue



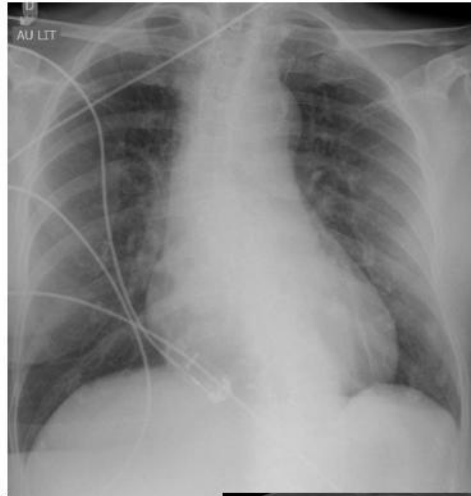
Élargissement diffus de la silhouette cardiaque en « carafe » sans anomalie parenchymateuse

TDM IV+ pour illustration

Flèche : épanchement péricardique



Dissection aortique



Élargissement médiastinal : signe très peu sensible +++

AngioTDM pour illustration.
Flèches : "flap intimal" séparant vrai et faux chenaux

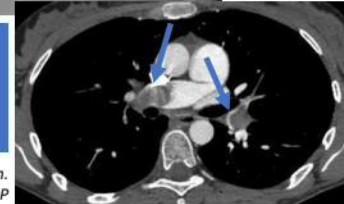


Embolie pulmonaire



Souvent normale (ici) ou anomalies non spécifiques. Aide éventuelle pour le diagnostic différentiel

AngioTDM pour illustration.
Flèches : thrombus dans les AP



Syndrome coronarien aigu

Radio normale
Aide éventuelle pour le diagnostic différentiel

234
359

Insuffisance cardiaque de l'adulte

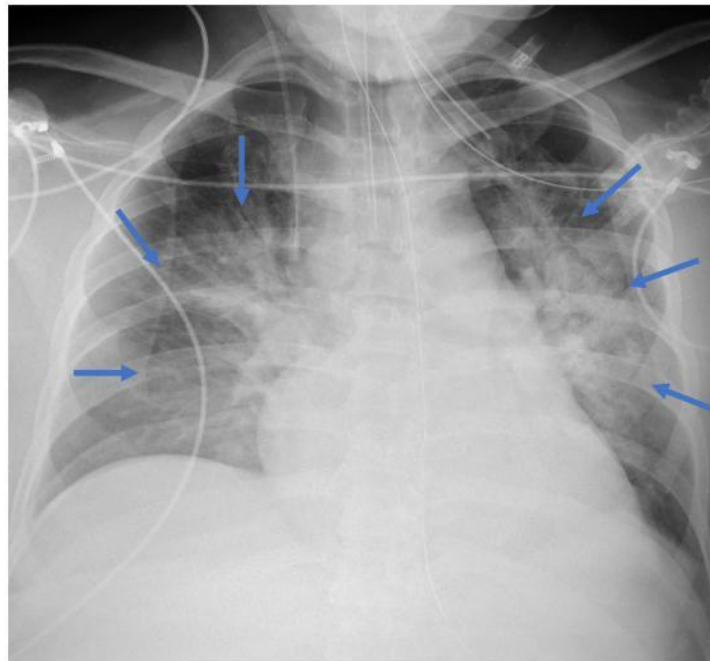
Détresse et insuffisance respiratoire aigüe du nourrisson, de l'enfant et de l'adulte

A. Connaître la sémilogie radiographique dans un OAP d'origine hémodynamique

A. Exemple de cliché thoracique d'œdème aigu du poumon d'origine hémodynamique

A. Savoir reconnaître un OAP sur une radiographie du thorax

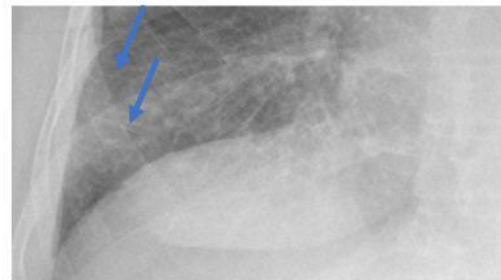
Radiographie de thorax de face (au lit)



Opacités peu denses, confluentes, à limites floues, de répartition périhilaire bilatérale (« aile de papillon »)

Signes supplémentaires si radio faite en position debout (rarement) : lignes de Kerley (voir encadré), redistribution vasculaire vers les sommets, cardiomégalie (ne s'apprécie pas sur une radio faite en position couchée), épanchement pleural

Zoom sur une radio de thorax de face debout (autre patient)



Opacités linéaires périphériques (flèches) : lignes de Kerley



Voir items 207

Œdème aigu du poumon